

NS

## THAIS COSTA SANTOS

IDADE: 29 PESO: 80 ALTURA: 151 PROFISSÃO: *escrituraria*  
 SINTOMAS: *Fazia apagação / Fotografia / confetaria*  
 QUEIXAS: *ronca muito - causação - refluxo*  
 MEDICAMENTOS: *Metformina / ansiolítico - fluoxetine*  
*testosterona / Resist. a insulina*  
 MÉDICO: *Dr. Priscila / Dr. Maria Beatriz*  
 EXERCÍCIO FÍSICO: *Ha (5) x 150*  
 HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: *5h* ALMOÇO: 5 LANCHE: 1830 JANTAR: -  
 HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 7h  
 COCHILLO ( ) SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM ( ) NÃO ( ) EVENTUAL  
 BEBIDA ALCOÓLICA ( ) SIM ( ) X NA SEMANA (X) NÃO 8 gatos (sugando).  
 FUMO ( ) SIM ( ) MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:  
 TIPO DE RESPIRAÇÃO: *mista* BANHEIRO: 2x / *Brucos*  
 CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: *gobosa* CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 33  
 OVERLAP: *não* MALLAMPATI: III IAH: 66.1 l/hv SPO2: 82%  
 PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Sono REM: 111 e/ev  
 CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Efic. sono 65.8%  
 HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: *→ mista / mista*  
 COMORBIDADE: ( ) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA ( ) CARDÍACA  
 (S) ORTOPÉDICA ( ) NEUROLÓGICA ( ) OUTROS  
*Dor lombar / Pescoço rodado a @ / ↓ peso 4kg.*

16/11 Avaliação  
23

19/12 P= 5.5 média  
23 M. de uso: 4:30  
fuga = 2.6 lpm.

Sua Cláudio

03/01 P= 6.5 cmH<sub>2</sub>O  
24 IAH= 0.6  
M. de uso: 5h

Comprou o CPAP pg.

Sua

26/01 P= 5.3 cmH<sub>2</sub>O  
24 IAH= 0.9 e/ev  
M. de uso:

Sua.

15/03 P= 5.1 cmH<sub>2</sub>O  
24 IAH= 0.7 e/ev  
M. de uso: 4h41'

Sua

27/05 P= 5.  
24 IAH= 0.5 e/ev  
Fuga = 0.4 lpm.  
M. de uso: 6h

Sua.



17/04/25

P= 5,1 cm H<sub>2</sub>O

IAH= 0,6 e/h

m de uso: 3h55

lung: 39,1 m

~~Relata utilizar a~~

Relata utilizar a

mascara durante

a noite

não utiliza desde 08/04  
pois a máscara quebrou

Matada

Nome: THAIS COSTA SANTOS

Data de Nascimento: 24-3-1994

IMC: 35,96

Sexo: Feminino

Data do exame: 14-09-2023

Peso: 82 kg

Altura: 1,51 m

Médico: DRA. PRISCILA LEITE DA  
SILVEIRA

Medicamentos:

Histórico:

### Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 14-09-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 506,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 99,5 e 92,5 minutos. O tempo total de sono foi de 333,0 min, eficiência de 65,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,4%; estágio N2: 50,8%; estágio N3: 23,0%; sono REM: 23,9%. O índice de despertares foi de 26,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 66,1/hora, sendo 3 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 364 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 82%, permanecendo 5,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 61 - 109 bpm e NREM de 59 - 116 bpm.

**CONCLUSÃO:** Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (13), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 66,1/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=82%);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

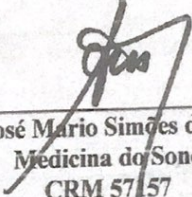
**Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.**

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

  
Dr. José Mario Simões da Costa  
Medicina do Sono  
CRM 57.57